

# Consentimiento de Ultrasonido Nivel II

## O más como parte del diagnóstico prenatal

Se me ha informado acerca de la necesidad de realizar un Estudio de Segundo nivel por médicos especialistas en Medicina Materno Fetal. He comprendido y aceptado que

- Se trata de una técnica que puede ser practicada por vía vaginal y/o abdominal (según la época de la gestación y condiciones) que permite la visualización del feto y su entorno (placenta, líquido amniótico, etc.).
- La ecografía o ultrasonido sólo puede informar de la existencia de posibles anomalías morfológicas y defectos congénitos de otra naturaleza (bioquímicos, metabólicos, genéticos, cromosómicos, etc.) Por tanto el resultado normal de mi estudio ecográfico no garantiza que el niño nacerá sin alteraciones morfológicas, enfermedades de la función de los diferentes órganos o retraso mental.

### Primer Trimestre:

- El estudio estructural del primer trimestre (11-13.6 semanas es la prueba de referencia para la detección de alteraciones en los cromosomas ( Trisomía 21, 18 y 13- Síndrome de Down, Edwards y Patau). Este estudio se realizará siguiendo las normas de la Sociedad Internacional de Ginecología y Obstetricia ( ISUOG, 2023) y las Guías de la Fetal Medicine Foundation, ( FMF, 2012). Con los datos incluidos en el cálculo de riesgo la capacidad de detección de la prueba es de alrededor del 70% si no se acompaña de marcadores bioquímicos, (pruebas sanguíneas). En caso de contar con datos de ultrasonido y marcadores bioquímicos, la prueba tiene una capacidad de detección cercana al 97% con una prueba de error de aproximadamente 3%. De cualquier forma, se considera un estudio de tamizaje y los resultados solo orientan a la realización o no de un estudio confirmatorio.

La capacidad de detección de alteraciones morfológicas o estructurales mejora cuando mejoramos la visibilidad y esto sucede cuando realizamos el abordaje vaginal. Es por ello que te sugerimos nos permitas realizar ambos abordajes. En esta etapa es posible diagnosticar aquellas que ponen en riesgo la vida, pero cada vez, hacemos diagnósticos más tempranos.

El diagnóstico del sexo fetal en esta etapa se puede ofrecer una certeza cercana al 80%, ya que los genitales externos aún no están formados. El descenso testicular es visible hasta las 24 semanas. Es por ello que en esta etapa el diagnóstico no es definitivo.

### Ultrasonido del Segundo Trimestre (18-22.6 semanas)

El estudio estructural del segundo trimestre es la prueba de referencia para la detección de anomalías estructurales fetales. Este estudio se realizará siguiendo las normas de la Sociedad Internacional de Ultrasonido en Ginecología y Obstetricia (ISUOG) o Con los

datos incluidos en el cálculo de riesgo la capacidad de detección de la prueba es de 72 % para alteraciones de los cromosomas (menos que el primer trimestre). En caso de las alteraciones estructurales la capacidad de detección es variada y depende del sistema evaluado así como la severidad de la alteración. Siempre es más sencillo diagnosticar lo más severo. Se aconseja en todos los casos realizar dicho estudio.

En algunos casos la detección será forzosamente tardía (infecciones fetales, algunas anomalías digestivas, obstrucciones urinarias o intestinales, displasias esqueléticas, hidrocefalia, alteraciones genitourinarias y algunas cardíacas, etc.) dado que tales patologías se originan y/o manifiestan en una etapa avanzada de la gestación.

### Ultrasonido del Tercer Trimestre (> 28 semanas)

Aunque no se considera un estudio de rutina, ha demostrado mejorar la detección de ciertas alteraciones estructurales tales como las hernias diafragmáticas (20%), las alteraciones urogenitales, y las alteraciones del sistema nervioso central. Es por ello que se recomienda realizar dicho estudio. Además permite evaluar el crecimiento fetal, considerar la anatomía y alteraciones placentarias y con ello preparar al equipo obstétrico para el nacimiento. En algunas personas se debe considerar realizarse de forma secuenciada sobre todo si los riesgos iniciales quedaron altos para alteraciones del crecimiento fetal o existen antecedentes de alteraciones estructurales, esto deberá decidirse en cada caso.

El ultrasonido, aunque orienta sobre la condición fetal, no tiene por sí sola un valor absoluto para asegurar el bienestar fetal.

- No se han demostrado daños directos hacia el feto.
- La capacidad de detección de esta prueba en todos los trimestres puede verse limitada por diversos factores tales como: características de la transmisión del ultrasonido, características maternas y posición fetal
- Las indicaciones aquí sugeridas no constituyen un actuar médico. Toda decisión médica y tratamiento son responsabilidad de su Obstetra tratante.
- En caso de encontrar alguna lo ideal es comunicarnos con su médico tratante, quien será el encargado de tomar decisiones acerca de mi caso. Sin embargo, se me ofrecerán los servicios que sean requeridos (Genética Perinatal, Cirugía Fetal, Neurosonografía fetal, Ecocardiografía Fetal, Resonancia Magnética, etc.)

Así pues, se me ha informado sobre las ventajas y las limitaciones de realizarme el estudio ultrasonográfico

He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y sencillo y el médico me ha permitido realizar todas las observaciones y me han aclarado las dudas que le he planteado.

• También comprendo que en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar el consentimiento que ahora presto.

---

**Nombre y firma del paciente**

---

**Testigo**

---

**Dra. María Nallely Moreno Uribe**

---

**Testigo**